



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : سماح جلال حمدي عبد الحفيظ

العنوان : الصوفي

الحي / المدينة : الفيوم

المحافظة : الفيوم

تاريخ تسجيل الإستمارة : 21-09-2026

رقم البطاقة : 28104052300326 رقم التليفون : 01023609376

العمر (تاريخ الميلاد) : 05-04-1981 المهنة : حاصل علي دبلوم

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... د/ د/ د/ د/

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: سماح جلال حمدي عبد الحفيظ National ID: 28104052300326	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



MDT form

A-Patient ID:

1- Name : سماح جلال حمدي عبدالحفيظ

Sex:

3- Medical number:

Female

83242515

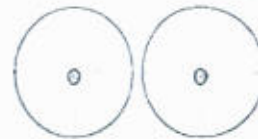
Old Med :

DATE:

3905-2024

2-ID number: 28104052300326

Patient Age : 44 Y



Family history

Family history
-VE

Phone

Phone

01007312400

BMI

BMI

REASON OF MDT

REASON OF MDT
POST OPERATIVE

marital status

Marital Status
(MARRIED)

NRS Score

NRS Score

GROUP

GROUP

Date of MDT

Date of MDT

2025-04-03 ☐

Co morbidity

Co Morbidity

Menopausal
status

Menopausal Status
POSTMENOPAUSAL

Initial STAGE

Initial STAGE

Clinical data

Breast Imaging :

11 o'clock 1x1.3 4 cm from nipple , 0.7 cm from skin
single pathological It axillary LN

Mets Workup :

CAP: FREE

BX IDC BX COMMENT	ER 8/8 ER COMMENT	PR 5/8 PR COMMENT	Her 2 Neu HER 2 Neu COMMENT -VE	SISH SISH COMMENT	Ki67 10
-------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------------------	----------------------	------------

T 1	N 0	M 0
--------	--------	--------

Sonomammography

cesm:lt breast UIQ unifocal pathological enhancing mass BIRADS 6

PATIENT HISTORY

LT WLE+SLNB: mixed IDC,ILC II PT1 (1.9CM)

free margin

free LN 0/5

MDT OUTCOME & PLAN

MDT OUTCOME & PLAN

1- ADJUVANT TAXOTERE ENDOXAN X4

2- PORT

3- ADJUVANT TAM

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	MEDICAL ONCOLOGY / /	RADIOLOGY	RADIOLOGY / /
SURGERY	SURGERY	PATHOLOGY	PATHOLOGY
Psychiatric	Psychiatric	Nutrition	Nutrition



Patient Name: Samah Galal Hamdy Abd Algiz	Date : 24/11/2024
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST	Age : 43 Year(s)
Medical ID: 3905/2024	Pat. ID: 94540

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -
Findings:

I Chest:

- Left breast upper inner quadrant enhancing mass measures 2x1 cm. Enlarged left axillary level I & II lymph nodes the largest at the latter measures 1.5x0.8 cm.
- Middle lobe traction bronchiectatic changes.
- Clear rest of both lung fields. No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitory lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is of average size with homogenous CT texture. No definite enhancing focal lesions or contour irregularities.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Patent homogenously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals. Circumferential-aortic left renal veins.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

***Scanned skeleton:** no definite worrisome lytic or sclerotic focal lesions.

Opinion:

- No evidence of pulmonary or hepatic metastatic deposits.

Dr. Shaimaa Megahed, MSc

Dr. Mohamed Mohsen, M.D.



Patient Name : سماح جلال حمدي عبدالحنيف
Patient No. : 28104052300326
Path No. : 7586/2024
Sex : Female
Age : 42 Y
Referring Doc : 2

Request No. : 110126831
Request Date : 09/10/2024
Verification Date : 20/10/2024
Financial Category : مبادرة
Department : مبادرة أورام ندي - سوهاج

Pathology Report

Primary sample: Paraffin Block 7413/2024 (left breast CORE BIOPSY)

Test: ER, PR, HER2neu and Ki67 (ER&PR: Harvery scoring system, Her2neu: CAP scoring system)

Technique: Sections were prepared with highly specific monoclonal mouse anti-human antibodies (MAbs) for Oestrogen receptors, Progesterone receptors and Her-2. DAB was used as an indicator and haematoxylin as a nuclear counter stain.

The sample received was treated by :- VENTANA anti- ER, PR, Ki67 and HER-2/neu (4B5) Rabbit monoclonal primary antibody using DAB detection kit in ventana benchmark GX.

Results:

- E-Cadherin :preserved membranous expression in invasive tumor cells
- ER: (strong) nuclear staining of (90%) of tumor cells.
- PR: (moderate) nuclear staining of (18%) of tumor cells.
- HER2neu: (negative) membranous staining of tumor cells.
- Ki67: Positive nuclear staining of (10%) of tumor cells.

Comment: Control is Her2 positive

Conclusion:

- E-Cadherin :positive expression indicate ductal origin
- ER: (SCORE 8/8).
- PR: (SCORE 5/8).
- HER2/neu protein over expression: Negative (SCORE 0).
- Ki67: the proliferation index of the tumor is 10%



Patient Name سماح جلال حمدي عبدالحفيظ
Patient No. 28104052300326
Path No. 7586/2024
Sex Female
Age 42 Y
Referreing Doc 2

Request No. 110126831
Request Date 09/10/2024
Verification Date 20/10/2024
Financial Category مبادرة
Department مبادرة أورام ندي - سوهاج

Pathology Report

Signature
Pathologist, Dr: Mohamed Nasr
Dr. Sarah Rafat



Patient Name	: سماح جلال حمدي عبدالحفيظ	Request No.	: 110124680
Patient No.	: 28104052300326	Request Date	: 03/10/2024
Path No.	: 7413/2024	Verification Date	: 08/10/2024
Sex	: Female	Financial Category	: مبادرة
Age	: 42 Y	Department	: مبادرة أورام ثدي - سوهاج
Referring Doc	: 2		

Pathology Report

CLINICAL DIAGNOSIS: Left breast mass .

NATURE OF SPECIMEN: TCNB.

GROSS EXAMINATION : The specimen consists of three tissue cores (0.7cm long) each, grayish in color, totally submitted in one cassette.

MICROSCOPIC EXAMINATION: Sections were reviewed.

DIAGNOSIS: Labeled as Left breast mass, TCNB;

The Features are consistent with invasive mammary carcinoma, grade II , favors lobular origin , for confirmation using E-Cadherin.

-No detected in-situ component.

Signature

Pathologist. Dr. Christeen Nady

Dr. Sarah Raafat

N.B : Specimens received at the department of pathology are examined and sampled for diagnostic purposes. The specimens are normally held for four weeks and then disposed. A request for return of the specimens must be made at the time of surgery or within four weeks.

Name: Samah Galal Hamdi Abdel Hafez

Date: 17-2-2025

Contrast enhanced Spectral Mammography

CLINICAL SUMMARY: 42 years old female with left carcinoma of ductal origin

CC & MLO low energy & recombined (post contrast) images

FINDINGS:

Background Uptake: minimal background enhancement

ACR: C (Heterogeneously dense breast)

LEFT BREAST:

- **Low energy (Non contrast) images:** UIQ irregular dense spiculated mass lesion with distortion
- **Recombined (Post contrast) images:** UIQ middle third moderate heterogeneously enhancing mass measures 1.6x1.1x1.4cm located 4.5cm from nipple
- Normal skin / nipple / areolar complex.
- **Complementary US:**
- 11:00 irregular hypoechoic spiculated mass , index lesion
- Non specific lymph node

RIGHT BREAST:

- **Low energy (Non contrast) images** No masses, asymmetry or distortion or suspicious microcalcifications.
- **Recombined (Post contrast) images** show, no pathological uptake.
- Normal skin / nipple / areolar complex.
- **Complementary ultrasound:**

IMPRESSION:

LEFT BREAST: UIQ unifocal pathological enhancing mass as described (BIRADS6 =pathologically proved malignancy)

RIGHT BREAST: (BIRADS 1= Normal)

Best regards,

Dr. Marwa Ramzy, MD, FRCR